

문제번호	8	교수님	교수님
주제	호흡 억제제의 원인	해설자	오성택
		감수자	
해설	아편유사제를 사용하여 암성통증을 치료할 때 부작용 호흡억제 작용: 주로 μ수용체에 작용되어 나타나는 현상으로 뇌의 호흡중추에 직접 작용하며 이산화탄소(CO_2)에 대한 반응성이 저하되어 호흡억제가 나타남 암 환자의 암성 통증 관리를 위해 투여한 진통제의 부작용으로 추정됩니다.		

문제번호	48	교수님	최원일 교수님
주제	천식의 급성악화	해설자	오성택
		감수자	
해설	2015 천식 진료지침) 급성 악화의 중증도 평가 중증 : 단어로 대화, 등을 굽히고 앞으로 구부정하게 있음, 안절부절 못함. 분당 호흡수 30회 이상, 호흡보조근 사용, 분당 심박수 120회 이상 일차 의료기관에서 치료 속효성 흡입 베타2 항진제, 전신 스테로이드(경구), 산소, 질병 조절제의 증량 응급실에서의 치료 빠른 회복을 위해 다음과 같은 치료를 동시에 시행 속효성 흡입 베타2 항진제, 전신 스테로이드(경구 / 정맥), 산소 응급실 체류 기간 동안의 흡입 스테로이드, 이프라트로피움(중등증 이상에서), 테오필린 ① 흡입용 부신피질 스테로이드 + 속효성 베타2 항진 복합제 흡입 ② 전신 부신피질 스테로이드 ③~⑤번 문항의 오답 근거는 2014 천식 진료지침에서 발췌하였습니다. ③ 급성 천식 악화에서 항류코트리엔제의 효과를 입증할 만한 정보는 거의 없다 ④ 천식 급성악화 환자에서정주 아미노필린 사용은 권고하지 않는다 ⑤ 흡입속효성베타작용제를 사용해도 충분한 기관지확장 효과를 얻을 수 없는 경우에 속효성 항콜린제를 같이 투여		

문제번호		교수님	박재석 교수님
주제	만성폐쇄성폐질환의 진단	해설자	오성택
		감수자	
해설	C) Airflow obstruction can be determined best by spirometry. If the ratio of FEV1 to forced vital capacity (FEV1/FVC) is less than 0.70 after administration of an inhaled bronchodilator 2014 COPD 진료지침) 환자의 정확한 진단을 위해, 기관지확장제를 흡입한 후에 폐활량을 측정하여, 기류제한 유무를 확인하며, 폐활량측정법을 하여 $FEV1/FVC < 0.70$이면 기류제한이 있다고 할 수 있음		

문제번호		교수님	박재석 교수님
주제	간질성 폐질환의 진단	해설자	오성택
		감수자	
해설	C) high-resolution computed tomography (HRCT) is essential in both the diagnosis and staging of ILD 환자의 병력과 폐기능 검사(제한성), CXR(Reticular pattern)에서 IIP를 의심할 수 있으며, IIP의 경우 HRCT를 필수적으로 실시		

문제번호		교수님	최원일 교수님
주제	천식의 병태생리	해설자	오성택
		감수자	
해설	2015 천식 진료지침) 천식 환자에서는 기도염증과 함께 기도의 특징적인 구조적 변화가 발생하는데, 이를 기도개형(airway remodeling)이라하며, 기도개형은 질환의 중증도와 연관이 있으며 비가역적 기도협착을 가져오기도 함		

문제번호		교수님	박재석 교수님
주제	만성폐쇄성폐질환의 급성 악화 : 보조 환기	해설자	오성택
		감수자	
해설	2014 COPD 진료지침) <u>비침습적 기계환기의 적응증(다음 중 한 가지에 해당될 때)</u> <u>호흡산증($pH \leq 7.35$ 또는 $PaCO_2 \geq 45$ mmHg), 호흡보조근의 사용, 역설적 복근운동, 또는 늑간수축(함몰)이 관찰될 정도의 심한 호흡곤란</u> <u>침습적 기계환기의 적응증(다음 중 한 가지에 해당될 때)</u> 비침습적 기계환기법을 환자가 견디지 못하거나 치료에 실패한 경우 호흡정지 또는 심정지 의식저하가 동반된 일시적 호흡정지 혹은 숨을 헐떡거릴 때 <u>의식상태의 저하 또는 정신운동초조(psychomotor agitation)</u> 에서 비침습적 기계환기의 적응증에 해당하는 환자가 의식이 저하되었으므로 기관 삽관 후 침습적 기계환기 보조를 시도		

문제번호		교수님	박재석 교수님
주제	만성폐쇄성폐질환의 치료	해설자	오성택
		감수자	
해설	2014 COPD 진료지침) <u>mMRC 1점, FEV1 50% 미만으로 Class C에 해당하며 LAMA를 우선적으로 고려</u> 2017 GOLD COPD Guideline) Refined ABCD Assessment tool Exacerbation & mMRC <u>급성 악화의 병력이 없고 mMRC 1점(약간 오르막을 걸어도 숨이 참)이므로 Class A에 해당하므로 Bronchodilator를 우선적으로 고려</u> 2017 GOLD COPD Guideline에서는 FEV1에 대한 기준이 삭제되었으며 2017년 7월 현재 2017 COPD 진료지침을 대한호흡기학회에서 개발 중에 있습니다. 2017학년도 기준 수업은 2017 GOLD COPD Guideline으로 진행되었습니다.		

문제번호		교수님	최원일 교수님
주제	천식의 치료	해설자	오성택
		감수자	
해설	2015 천식 진료지침) <u>1단계 치료</u> 천식 주간 증상 또는 증상완화제의 사용이 한 달에 1번 이하 지난 1달 간 천식으로 인한 수면장애가 없는 경우 질병조절제는 불필요하며 필요할 때 속효성 베타2 항진제 등의 증상완화제를 흡입		

문제번호		교수님	박재석 교수님
주제	폐농양의 치료	해설자	오성택
		감수자	
해설	H) 임상증상(발열, 악취가 나는 객담)과 호중구 증가, CXR을 통해 폐농양을 진단 항생제가 폐농양의 1차 치료로 ampicillin-sulbactam or clindamycin을 선호		

문제번호		교수님	최원일 교수님
주제	천식의 진단	해설자	오성택
		감수자	
해설	2014 천식 진료지침) <u>진단 당시 기류제한이 없는 경우에는</u> 가변적인 기류제한을 기도과민성으로 확인 기관지유발검사는 기도과민성을 평가하는 방법으로, 천식이 의심되지만 정상 호흡음이 들리거나 또는 정상 폐기능을 보이는 환자에서 유용한 검사		

문제번호		교수님	박재석 교수님
주제	폐렴의 원인균	해설자	오성택
		감수자	
해설	강의록) 2개씩 붙어있는 균은 폐렴구균(폐렴 쌍구균)		

문제번호		교수님	장정희 교수님
주제	호흡기계 약물 : 비충혈 완화	해설자	오성택
		감수자	
해설	강의록) ③ Phenylephrine은 알파 수용체에만 작용하는 약물로 비충혈 완화를 위해 사용되나, 심장에 직접 작용하는 효과는 없음		

문제번호		교수님	이성용 교수님
주제	호흡기계 약물 : 기관지 확장제	해설자	오성택
		감수자	
해설	2014 COPD 진료지침) COPD에 사용하는 기관지 확장제 : 베타-2작용제, 항콜린제, 메틸잔틴 ① 문제가 되는 독성작용으로는 심방 및 심실부정맥 ② 천식에 사용하는 질병 조절제 ③ 천식의 급성 악화에 아나필락시 쇼크가 동반되는 경우 등에만 사용하며 COPD 진료 지침에는 언급되지 않은 약물 ④ SAMA ⑤ 고혈압 치료 약제		

문제번호		교수님	장정희 교수님
주제	호흡기계 약물 : 폐렴 항생제	해설자	오성택
		감수자	
해설	강의를) 지용성, 염증과 상관없이 침투 용이한 항생제 : Fluoroquinolone, New macrolides, Tetracycline, Clindamycin, TMP/SMX 농도 의존적 항생제 : Fluoroquinolone 지역사회획득폐렴의 치료에 사용하는 항생제 : β -lactam $\pm$ macrolide, Respiratory fluoroquinolone 해당 내용에 모두 만족하는 항생제는 Respiratory fluoroquinolone에 해당하는 Moxifloxacin		

문제번호		교수님	박재석 교수님
주제	간질성 폐질환의 진단	해설자	오성택
		감수자	
해설	환자의 병력, 혈액검사, 폐기능검사, HRCT에서 간질성 폐질환을 의심하고 추가 검사를 진행 C) / 강의록) An approach to interstitial lung disease 상에서 나와있는 검사 ① IIP가 의심되나 HRCT 소견이 전형적이지 않아, 추가 검사가 필요한 경우 Muscle, kidney, fat, sinus biopsy Specific serologies or biopsy of nonlung tissue to diagnose connective tissue or other systemic disease ② 검사 1에서 전신 질환이 발견되지 않은 경우 BAL,과 TLB를 실시 ③ 검사 2에서 진단이 되지 않은 경우 Surgical lung biopsy를 실시 ① 진단 알고리즘에 없음 ② 진단 알고리즘에 없음 ③ 진단 알고리즘에 없음 ④ 진단 알고리즘에 없음(FNA가 아닌 BAL과 TLB를 시도해 볼 수도 있음) ⑤ VATS Biopsy가 진단 알고리즘에 있음 강의록의 NSIP의 사진이었으므로 NSIP에 대한 Cecil 25th 설명을 부연합니다. C) The diagnosis of fibrotic nonspecific interstitial pneumonia can be ascertained only by the histologic features in a surgical lung biopsy specimen.		